EXAMEN BLANC 2026 / SESSION SEPTEMBRE 2026 ÉPREUVE DE SI EN CHIRURGIE

DURÉE : 1 H 30 / VERSION A

CAS CLINIQUE N° 1

Réponse juste : +1 pt ; réponse fausse et sans réponse : 0 pt.

Stagiaire au service de chirurgie du CHR de MAN, vous recevez pendant votre permanence l'enfant Kapen, 3 ans, pesant 14 kg, présentant une insuffisance cardiaque pour brûlure. Le bilan des lésions met en évidence :

• Une brûlure de la face

• Une brûlure de la cuisse gauche jusqu'à la jambe homolatérale

• Une brûlure de la main gauche

• Une brûlure de la moitié inférieure du tronc antérieur

1. L'infirmier vous demande de l'aider à évaluer l'étendue de la brûlure selon la table de Lund et Browder. Indiquer la formule générale de Baxter que vous appliquerez à Kapen à J2 parmi ces propositions.

A. QJ2 = 40 kg × SCB

B. QJ2 = 4 × Pds (kg) × SCB

C. QJ2 = 80 kg × SCB

D. QJ2 = 2 × Pds (kg) × SCB

2. Indiquer parmi ces propositions la formule spécifique de Baxter applicable à l'enfant Kapen à J1.

A. QJ1 = 28 kg × SCB

B. QJ1 = 2 × Pds × SCB

C. QJ1 = 56 kg × SCB

D. QJ1 = 4 × Pds × SCB

3. Indiquer parmi ces propositions la surface corporelle brûlée au niveau du squelette axial de l'enfant Kapen.

A. SCB = 14,5 %

B. SCB = 15 %

C. SCB = 29,5 %

D. SCB = 30 %

E. SCB = 44,5 %

4. Indiquer parmi ces propositions la surface corporelle brûlée au niveau du squelette appendiculaire de l'enfant Kapen.

A. SCB = 44,5 %

B. SCB = 30 %

C. SCB = 29,5 %

D. SCB = 15 %

E. SCB = 14 %

5. Calculez la surface corporelle totale brûlée de l’enfant Kapen. Indiquer votre résultat parmi les propositions ci-dessous.

A. SCB = 44,5 %

B. SCB = 30 %

C. SCB = 29 %

D. SCB = 15 %

E. SCB = 14,5 %

6. Ces événements ci-dessous se sont succédé lors de la brûlure de l’enfant Kapen. Classer les par ordre chronologique de survenue.

1. Exsudation plasmatique

2. Anoxie tissulaire

3. Hypovolémie

4. Trouble de la perméabilité capillaire

Indiquer le résultat de votre classification parmi ces propositions ci-après.

A. 1-2-3-4

B. 4-3-2-1

C. 4-1-3-2

7. Sachant que votre condisciple était témoin de l’accident, indiquer parmi ces propositions trois actions à accomplir en sa qualité de premier secouriste.

A. Rupture des phlyctènes

B. Refroidissement de la victime à l’eau froide

C. Prévention du tétanos par injection de SAT

D. Couvrir la victime par un drap propre

E. Pansement avec topique traditionnel

F. Isolation thermique de la victime

8. Indiquer chez l’enfant Kapen les trois facteurs qui le prédisposent à des complications infectieuses parmi ces suggestions.

A. L’œdème pulmonaire

B. La rupture de la barrière cutanée

C. L’inhalation de fumées

D. La translocation bactérienne

E. Les troubles de l’hémostase

F. La dépression immunitaire marquée

9. Plusieurs paramètres sont considérés comme critères de gravité des brûlures. Indiquer en vous appuyant sur le cas clinique les critères de gravité de l’enfant Kapen parmi les propositions ci-dessous.

A. Les circonstances de survenue de la brûlure

B. La localisation de la brûlure

C. La profondeur de la brûlure

D. Les lésions associées à la brûlure

E. La superficie de la brûlure

F. Les tares associées à la brûlure

10. Relever selon le cas clinique les localisations de gravité des brûlures de l’enfant Kapen.

A. Le visage

B. Les parties génitales

C. La main gauche

D. La surface corporelle brûlée

E. Le genou gauche

F. Le terrain

11. Indiquer la valeur numérique de la quantité de liquide à perfuser à l’enfant Kapen à J1.

A. QJ1 = 8,4

B. QJ1 = 16,24

C. QJ1 = 16,52

D. QJ1 = 8,26

12. Indiquer la valeur numérique de la quantité de liquide à perfuser à l’enfant Kapen à J2.

A. QJ2 = 8,4

B. QJ2 = 16,52

C. QJ2 = 8,26

D. QJ2 = 8,12

13. Calculer l’indice de Baux de l’enfant Kapen et indiquer votre réponse parmi ces propositions.

A. IB = 32

B. IB = 47

C. IB = 29,5

D. IB = 47,5

14. Indiquer parmi ces propositions le pronostic vital de l’enfant Kapen.

A. La guérison est infiniment probable

B. La mort est quasi certaine

C. Le brûlé a une chance sur deux de guérison

15. En vous appuyant sur les formules, indiquer l’unité de QJ1 et QJ2 parmi ces propositions.

A. Millilitre

B. Centilitre

C. Litre

D. Kilogramme

E. Décilitre

16. L’enfant Kapen devra bénéficier d’une surveillance infirmière très soutenue. Indiquer parmi ces éléments de surveillance celui qui est en rapport avec la réanimation hydroélectrolytique.

A. La température

B. Le pouls

C. La respiration

D. La diurèse

E. L’alimentation

CAS CLINIQUE N° 2

Réponse juste : +1 pt ; réponse fausse : 0 pt ; aucune réponse : 0 pt.

Stagiaire au CHR de MAN, pendant votre permanence alors que l'infirmier s'est retiré pour sa pause déjeuner, vous recevez monsieur Gbé. Voici les faits rapportés par celui-ci à l'interrogatoire : « Docteur, depuis près de dix jours je ne fais pas de selle ni de vent. En tous cas je sens un inconfort au ventre avec des douleurs vives. Vraiment docteur, aidez-moi, ça ne va, je ne veux pas mourir ! » s'exclame-t-il tout en larmes.

17. Selon les faits rapportés par M. Gbé, indiquer votre première conduite à tenir vis-à-vis de celui-ci parmi les propositions suivantes.

A. Examiner le malade

B. Informer l'infirmier

C. Prendre les constantes

D. Préparation psychologique

18. Indiquer deux contenus de cette première conduite tenue plus haut parmi ces propositions.

A. Inspecter le patient

B. Rassurer le malade

C. Appel téléphonique de l'infirmier

D. Mettre le malade en confiance

E. Inscrire les constantes dans le dossier

19. Indiquer parmi ces propositions l'affection dont souffre M. Gbé.

A. Appendicite aiguë

B. Péritonite aiguë

C. Occlusion intestinale

D. Hernie étranglée

20. Indiquer selon le texte les signes fonctionnels de cette affection rapportés par M. Gbé parmi les propositions suivantes.

A. Douleur à la fosse iliaque droite

B. Vomissement bilieux fécaloïde

C. Douleur abdominale vive

D. Météorisme abdominal

E. Température élevée

F. Arrêt des matières et des gaz

21. Indiquer parmi ces propositions un signe physique de cette affection que vous pouvez rechercher chez M. Gbé.

A. Douleur à la fosse iliaque droite

B. Vomissement bilieux fécaloïde

C. Douleur abdominale vive

D. Météorisme abdominal

E. Température élevée

F. Arrêt des matières et des gaz

22. Indiquer parmi ces propositions deux moyens dont vous disposez pour mettre en évidence ce signe physique.

A. Auscultation

B. L'inspection

C. L'interrogatoire

D. L'ASP

E. La palpation

23. En vous appuyant sur les signes rapportés par le malade, indiquer le siège de cette affection parmi les propositions suivantes.

A. La fosse iliaque droite

B. La fosse iliaque gauche

C. L'intestin grêle

D. Le côlon

Informé des résultats de vos investigations, l'infirmier vous demande de prescrire des examens complémentaires.

24. Indiquer les examens radiologiques que vous pouvez prescrire à M. Gbé parmi ces propositions.

A. L'ASP

B. L'échographie abdominale

C. Lavement baryté

D. Ionogramme sanguin

E. Numération formule sanguine

25. Indiquer parmi ces propositions les résultats éventuels des examens radiologiques.

A. Côlon partiellement injecté de baryte

B. Désordre hydroélectrolytique

C. Hématocrite élevé

D. Niveau hydroaérique

E. Côlon totalement injecté

26. Indiquer le résultat de l'ionogramme sanguin parmi ces propositions.

A. Côlon partiellement injecté de baryte

B. Désordre hydroélectrolytique

C. Hématocrite élevé

D. Niveau hydroaérique

E. Côlon totalement injecté

27. L'infirmier vous demande d'entamer la prise en charge médicale de M. Gbé. Indiquer les actes que vous pouvez poser parmi les propositions suivantes.

A. Préparation physique du malade

B. Prise d'une voie veineuse

C. Pose d'une sonde nasogastrique

D. Préparation de la chambre du malade

E. Installation du malade

F. Prélèvement sanguin

28. Indiquer parmi ces propositions les actes infirmiers que vous pouvez réaliser avant l'arrivée de l'infirmier.

A. Prise d'une voie veineuse

B. Préparation physique du malade

C. Pose d'une sonde nasogastrique

D. Préparation de la chambre du malade

E. Prélèvement sanguin

F. Installation du malade

29. L'infirmier vous demande de préparer le champ opératoire. Indiquer l'ordre chronologique de cette préparation physique parmi ces propositions.

A. Rasage / Détersion / Désinfection

B. Rasage / Désinfection / Détersion

C. Détersion / Désinfection / Rasage

D. Détersion / Rasage / Désinfection

30. Le chirurgien décide de réaliser une laparotomie. Indiquer deux buts visés par le chirurgien en réalisant ce type d'intervention.

A. But de réaliser une hémostase

B. But diagnostic

C. But de réaliser une ponction

D. But de réaliser une endoscopie

E. But thérapeutique

F. But de poser une sonde d'aspiration

31. Indiquer les actes à accomplir dans la période peropératoire parmi les propositions ci-dessous.

A. Surveillance de drains

B. Élaborer une fiche de surveillance

C. Surveillance du pansement

D. Réfection du lit du malade

E. Favoriser le lever précoce

F. Installer le matériel d'oxygénothérapie

32. Indiquer les actes à accomplir dans la période postopératoire de M. Gbé parmi les propositions ci-dessous.

A. Surveillance de drains

B. Élaborer une fiche de surveillance

C. Surveillance du pansement

D. Réfection du lit du malade

E. Favoriser le lever précoce

F. Installer le matériel d'oxygénothérapie

33. Indiquer parmi ces propositions l'intérêt de surveiller le pansement et les drains.

A. Prévenir les phlébites

B. Prévenir le syndrome de Mendelson

C. Prévenir les hémorragies

D. Déceler une hémorragie

34. Indiquer parmi ces propositions le phénomène qui témoigne de la réussite de l'intervention.

A. Le réveil du malade

B. La perméabilité des drains

C. La reprise du transit intestinal

D. L'absence d'hémorragie

QCM

1 pt par item juste / 0 pt par item faux et item non répondu.

35. Indiquer parmi ces propositions les deux signes que peut rapporter la victime en cas de fracture.

A. Une douleur vive

B. Une déformation

C. Une mobilité anormale

D. Une impotence fonctionnelle

E. Une crépitation osseuse

36. Indiquer parmi ces propositions trois signes que peut rechercher le praticien en cas de fracture.

A. Une déformation

B. Une douleur vive

C. Une mobilité anormale

D. Une impotence fonctionnelle

E. Une crépitation osseuse

37. Indiquer la variété de déplacement qui traduit un chevauchement parmi ces propositions.

A. Déplacement transversal

B. Déplacement angulaire

C. Déplacement longitudinal

D. Déplacement rotatoire

38. Indiquer la variété de déplacement qui traduit le déplacement en baïonnette parmi ces propositions.

A. Déplacement transversal

B. Déplacement angulaire

C. Déplacement longitudinal

D. Déplacement rotatoire

39. Indiquer l'ordre chronologique de la prise en charge orthopédique d'une fracture.

A. Rééducation / Réduction / Contention

B. Réduction / Rééducation / Contention

C. Contention / Rééducation / Réduction

D. Contention / Réduction / Rééducation

E. Réduction / Contention / Rééducation

40. Indiquer parmi ces propositions l’examen de confirmation d’une fracture.

A. L’échographie

B. L’EEG

C. La radiographie

D. L’ECG

41. Indiquer parmi ces propositions trois signes que peut mettre en évidence l’examen de confirmation d’une fracture.

A. La déformation

B. Le type de fracture

C. La mobilité anormale

D. Le déplacement des fragments osseux

E. La crépitation osseuse

F. Les lésions associées

42. Indiquer les types de fractures parmi les propositions ci-dessous.

A. Fracture fermée

B. Fracture incomplète

C. Fracture ouverte

D. Fracture en bois vert

E. Fracture complète

43. Indiquer une variété de fracture incomplète parmi ces propositions.

A. Fracture simple

B. Fracture à étage

C. Fracture en bois vert

D. Fracture comminutive

44. Relier chaque local du bloc opératoire à son destinataire.

Locaux du bloc opératoire	**Destinataire**
A. Salle de réveil	1. Panseur
B. Salle d’eau	2. Malade
C. Salle de stérilisation	3. Chirurgien
D. Salle d’hospitalisation	

A. (D, 1) / (C, 2) / (A, 3)

B. (D, 3) / (B, 2) / (C, 1)

C. (A, 2) / (B, 3) / (C, 1)

D. (B, 2) / (C, 2) / (A, 3)

45. Indiquer parmi ces propositions l'ordre chronologique de préparation d'un champ opératoire.

A. Rasage / Détersion / Désinfection

B. Détersion / Rasage / Désinfection

C. Désinfection / Rasage / Détersion

D. Rasage / Désinfection / Détersion

46. Indiquer parmi ces propositions le besoin prioritaire chez l'occlus du côlon.

A. Besoin de dormir et se reposer

B. Besoin de manger et boire

C. Besoin d'éliminer

D. Besoin d'être propre, soigné et protéger ses téguments

47. Indiquer dans les suites opératoires deux avantages du lever précoce parmi ces propositions.

A. Prévient les chocs hémodynamiques

B. Lutte contre l'infection

C. Favorise la cicatrisation

D. Accélère la reprise du transit

E. Prévient les hémorragies

F. Prévient la stase et l'obstruction bronchique

48. Parmi ces gestes, deux peuvent être accomplis dans un établissement de premier contact par l'infirmier. Indiquer les.

A. Pose d'une sonde nasogastrique

B. Pose d'une voie veineuse

C. Préparation du champ opératoire

D. Effectuer la prémédication

E. Établir une feuille d'évacuation

49. Parmi ces propositions, indiquer le besoin prioritaire chez l'occlus du grêle.

A. Besoin d'éliminer

B. Besoin de dormir et se reposer

C. Besoin de manger et boire

D. Besoin de respirer

QCD

Une réponse juste = 1 pt ; une réponse fausse = -1 pt ; une question non répondue = 0 pt.

50. Dans l'occlusion intestinale, le lavement baryté s'effectue en cas de perforation intestinale.

A. VRAI

B. FAUX

51. Dans les occlusions intestinales hautes, les vomissements sont tardifs alors qu'ils sont précoces dans les occlusions basses.

A. VRAI

B. FAUX

52. Les occlusions hautes siègent au niveau du côlon et les occlusions basses au niveau du grêle.

A. VRAI

B. FAUX

53. La péritonite se manifeste par une triade de signes fonctionnels et un signe physique.

A. VRAI

B. FAUX

54. Le signe physique de l’occlusion est la contracture abdominale alors que celui de la péritonite est le météorisme abdominal.

A. VRAI

B. FAUX

EXAMEN BLANC INFAS DALOA - SEPTEMBRE 2026

ÉPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN MÉDECINE

Durée : 1 h Version C

QCD : 1 réponse juste = +1 ; 1 réponse fausse = -1 ; sans réponse = 0.

QCM : 1 réponse juste = +1 ; 1 réponse fausse = -1 ; sans réponse = 0.

EXERCICE 1 : QCM - Cocher la ou les bonnes réponses

En service au CHU de Treichville, vous avez en charge ce jour M. Sangaré, âgé de 45 ans pour une taille de 1,70 m. Il est très affaibli, a une langue pâteuse, se plaint de céphalées et de douleurs diverses. Il refuse de manger. Sa température est de 40 °C, une TA de 11/7 cmHg pour un pouls de 100 puls/min.

01. À quelle affection pensez-vous ?

A. Paludisme

B. Fièvre typhoïde

C. Méningite

02. Quels sont les signes qui militent en faveur de votre diagnostic ?

A. Asthénie

B. Myalgie

C. Fièvre

D. Pouls

E. Tension artérielle

F. Céphalées

03. Parmi les examens ci-dessous demandés par le médecin, lequel est à propos ?

A. NFS

B. Goutte épaisse

C. PL

04. Quelles sont les complications qui peuvent être liées à cette affection ?

A. Anémie

B. Encéphalite

C. Hémorragie digestive

D. Ictère

E. Abcès du foie

05. Sachant que M. Sangaré a un IMC de 17,30, quel est son poids ?

A. 49 kg

B. 50 kg

C. 51 kg

06. Quels sont les besoins prioritaires de M. Sangaré ?

A. Besoin de manger et boire

B. Besoin de maintenir la température du corps dans les limites de la normale

C. Besoin de dormir et se reposer

D. Besoin d’éviter les dangers

E. Besoin d’apprendre

07. M. Zodo, âgé de 35 ans, souffre d'un paludisme grave. Quel traitement lui conseillez-vous en première intention ?

A. Artésunate inj.

B. Artéméther inj.

C. Sels de quinine en perfusion

D. Sels de quinine par voie orale

E. CTA

08. La posologie usuelle des sels de quinine étant de 24 mg/kg/j, combien de comprimés de Quinimax dosé à 500 mg doit prendre un patient de 60 kg par jour ?

A. 1 comprimé

B. 2 comprimés

C. 3 comprimés

09. La complication la plus fréquente dans l'ulcère gastroduodénal est :

A. Hémorragie digestive haute

B. Rectorragie

C. Hémoptysie

10. En présence d'une forte douleur abdominale, un abdomen tendu et de la fièvre, vous pensez à :

A. Une péritonite

B. Une fièvre typhoïde

C. Une occlusion

11. Une femme vient d'accoucher dans votre centre de santé. Quel est l'algorithme utilisé pour son dépistage VIH ?

A. Determine ensuite Stat-Pak

B. Stat-Pak ensuite Determine

C. Determine seul ou Stat-Pak seul

12. Cette femme est déclarée séropositive au VIH 1 et 2 : cocher la réponse juste.

A. Nous attendons le bilan initial avant de la mettre sous traitement

B. Nous la mettons sous traitement sans attendre le bilan initial

C. Le bilan initial est facultatif dans ce cas

13. Quel est le traitement adéquat pour la prise en charge de la mère qui refuse les contraceptifs ?

A. TDF 3TC DTG

B. TDF 3TC EFV

C. TDF 3TC LPV

14. La mère n'a pas suivi de traitement ARV tout au long de sa grossesse. Quel est le traitement ARV prophylactique pour le nouveau-né pendant 6 semaines ?

A. AZT plus NVP

B. AZT seul

C. Névirapine seule

15. Malheureusement, la mère n'a pas donné les médicaments convenablement au nouveau-né et la PCR à 6 semaines est revenue positive. Quel traitement ARV faut-il donner au nouveau-né ?

A. ABC 3TC LPV/r sirop

B. ABC 3TC LPV/r granulé

C. ABC 3TC LPV/r comprimé

16. Dans le cadre de l'index testing, le mari est dépisté séronégatif mais désire avoir toujours des rapports sexuels non protégés avec sa femme. Quelle prophylaxie préexposition préconisez-vous ?

A. TDF 3TC : 1 comprimé pendant toute la durée de l'exposition

B. TDF 3TC : 2 comprimés en prise unique 2 à 24 h avant la prise du risque, puis 1 comprimé à environ 24 h (+/-2 h) après la première prise ; enfin 1 comprimé 24 h (+/-2 h) après la deuxième prise

C. TDF 3TC : 1 comprimé 2 fois/j pendant toute la durée de l'exposition

17. Comment se fait la surveillance biologique de la mère avec la charge virale la première année ?

A. Tous les trois mois

B. Tous les six mois

C. Tous les douze mois

18. Comment se fait la surveillance biologique du nouveau-né le premier semestre au niveau de la charge virale ?

A. Tous les un mois

B. Tous les deux mois

C. Tous les trois mois

19. La sage-femme, ayant fait un accident d'exposition au sang avec la même patiente, se retrouve chez le médecin. Quelle prophylaxie le médecin lui donne-t-il ?

A. TDF 3TC EFV

B. TDF 3TC LPV/r

C. TDF 3TC DTG

20. Les œdèmes des membres inférieurs résultent :

A. D'une infiltration du tissu interstitiel par les lipides

B. D'une infiltration du tissu interstitiel par une thrombose veineuse

C. D'une infiltration du tissu interstitiel par un liquide séreux

21. Que signifie le terme dyspnée ?

A. Respiration par le nez

B. Gêne respiration

C. Difficulté à inspirer par le nez

22. Que signifie polypnée ?

A. Respiration lente

B. Respiration difficile

C. Respiration rapide et superficielle

23. La dyspnée d'origine cardiaque est :

A. Liée à un effort et s'interrompt au bout de 3 min

B. Liée à un effort et s'interrompt au bout de quelques heures après l'arrêt de l'effort

C. Liée à l'effort et s'accroît avec celui-ci et disparaît quelques minutes après l'arrêt de l'effort

24. Vous devez injecter 3,5 mg de Gentalline en IM. Sachant qu'une ampoule contient 10 mg pour 2 ml, quelle quantité prélèverez-vous ?

A. 0,3 ml

B. 0,7 ml

C. 0,5 ml

25. Combien de types de diabète existe-t-il ?

A. Un type

B. Deux types

C. Trois types

26. Parmi les signes suivants, deux relèvent du diabète de type 1, lesquels ?

A. Mictions fréquentes

B. Amaigrissement

C. [Proposition coupée dans le document d'origine]

D. [Proposition coupée dans le document d'origine]

E. Dyspnée

27. Pour un patient ayant une valeur de l'hémoglobine glyquée HbA1C à 7 %, quel sera son taux en glycémie ?

A. 1,2 g/l

B. 1,5 g/l

C. 1,8 g/l

28. À partir de quelle valeur parle-t-on de diabète chez un patient ?

A. 1,26 g/l

B. 6,5 mmol/l

C. 0,8 g/l

D. 3,5 % HbA1C

E. 11 mmol/l

29. Une perfusion d'un soluté de 400 ml dont le débit est de 25 gouttes/min doit passer en :

A. 5 h 30 min

B. 5 h 33 min

C. 5 h 40 min

30. L'écouvillonnage nasopharyngé se fait :

A. Par la voie buccale

B. Par la voie nasale

C. Par les deux voies

31. On peut observer dans un épanchement pleural liquidien :

A. Une hypersonorité

B. Une matité d'un hémithorax

C. Une abolition des vibrations vocales

D. Un souffle tubaire

E. Des râles crépitants

32. Parmi les risques suivants liés au sondage urinaire, un est faux, lequel ?

A. Non-respect des règles d'hygiène

B. Non-respect des règles d'asepsie lors des manipulations

C. Au respect du système clos

EXERCICE 2 : QCD - Cocher : A = Vrai ; B = Faux

33. La corticothérapie est contre-indiquée chez un patient ayant reçu un vaccin vivant.

A. VRAI

B. FAUX

34. Les personnes vivant avec le VIH doivent être privilégiées dans toute la société.

A. VRAI

B. FAUX

35. L'hôte intermédiaire de la dracunculose est un crustacé d'eau douce appelé cyclops.

A. VRAI

B. FAUX

36. L'ascaris peut entraîner une occlusion intestinale.

A. VRAI

B. FAUX

37. Dans les syndromes dysentériques, les germes responsables sont uniquement des bactéries.

A. VRAI

B. FAUX

38. Le prélèvement pour une gazométrie se fait dans une artère radiale ou humérale.

A. VRAI

B. FAUX

39. La contamination de la tuberculose est strictement interhumaine.

A. VRAI

B. FAUX

40. L'hématémèse est l'émission de sang rouge par la bouche dans un effort de vomissement.

A. VRAI

B. FAUX

41. Le venin des vipéridés est neurotoxique et entraîne des paralysies généralisées.

A. VRAI

B. FAUX

42. Le but du traitement du diabète est de normaliser le taux de sucre dans le sang.

A. VRAI

B. FAUX

43. Le pancréas est une glande qui joue un rôle de régulation du sucre dans l'organisme humain.

A. VRAI

B. FAUX

44. Le diabète de type 2 est causé par un dysfonctionnement du pancréas.

A. VRAI

B. FAUX

45. L'HTA peut se révéler par des signes fonctionnels ou lors d'une consultation fortuite.

A. VRAI

B. FAUX

46. La pollakiurie porte sur la quantité d'urine émise en 24 h.

A. VRAI

B. FAUX

47. La polyurie est portée sur la quantité des urines de 24 h.

A. VRAI

B. FAUX

48. L'incontinence urinaire est synonyme d'énurésie.

A. VRAI

B. FAUX

49. La hernie hiatale est caractérisée par le reflux gastroœsophagien.

A. VRAI

B. FAUX

50. La corticothérapie peut être considérée comme un dopage chez un sportif.

A. VRAI

B. FAUX

UP de Médecine

Bonne chance à tous !

EXAMEN BLANC INFAS DALOA - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN PÉDIATRIE

QCM

1. Tous les facteurs suivants inhibent le réflexe ocytocique chez la mère, sauf un. Cocher l'intrus.

a	La vue de son bébé
b	La douleur physique
c	Le manque de confiance en soi
d	La crise d'anxiété

2. Nouveau-né GG, sexe masculin, est âgé de 5 jours. Il vit avec sa mère à Grand Yapo. La mère réalise les soins du cordon avec une décoction de plante traditionnelle. L'examen somatique de GG est normal. La réalité personnelle de GG comporte :

a	4 données de dépendance
b	5 données de dépendance
c	3 données de dépendance
d	2 données de dépendance

3. L'échographie réalisée au premier trimestre de la grossesse vise les objectifs suivants sauf un. Cocher l'intrus.

a	Confirmer la grossesse
b	Estimer le risque trisomie
c	Apprécier l'activité cardiaque de l'embryon
d	Rechercher des malformations

4. Les signes suivants sont ceux du kwashiorkor sauf un. Lequel ?

a	Enfant grognon
b	Ulcération et desquamation
c	Alopécie
d	Bouffissure du visage

5. Durant la prise en charge de l'enfant malnutri, je surveille tous les paramètres suivants sauf un. Cocher ce paramètre.

a	Le retour de l'appétit
b	La prise de poids
c	La guérison des lésions
d	La régression des œdèmes

6. Les cellules qui produisent le lait maternel sont appelées :

a	Cellules souches
b	Cellule épidermique
c	Cellules épithéliales
d	Cellules myoépithéliales

7. BH est âgé de 2 ans et pèse 12 kg. Il est correctement nourri. Sa surface corporelle est estimée à :

a	0,2 m²
b	0,4 m²
c	0,5 m²
d	0,6 m²

8. L'infection bactérienne du nouveau-né précoce survient entre :

a	0 et 7 jours
b	7 et 8 jours
c	8 et 16 jours
d	16 et 28 jours

9. Vous collaborez à la réalisation des examens suivants en cas de fièvre aiguë, sauf un, lequel ?

a	Hémoculture
b	ECBU
c	Analyse LCR
d	Sérodiagnostic de Widal et Félix

10. Un enfant qui fait de la fièvre avec une bonne tolérance présente :

a	Une conscience altérée
b	Des marbrures
c	Un faciès vultueux
d	Un teint grisâtre

11. Une femme rhésus négatif accouche d'un enfant rhésus positif. Elle n'a pas eu le sérum anti-D. Dans une telle situation, le nouveau-né :

a	Doit téter les seins comme les autres enfants
b	Ne doit pas téter les seins comme les autres enfants
c	Doit être nourri au biberon
d	Doit recevoir le sérum antitétanique en sous-cutané

12. Les facteurs de risque de survenue des convulsions, liés à l'enfant, sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Faible poids de naissance
b	Céphalhématome
c	Traumatisme crânien
d	Malnutrition

13. Les rôles de collaboration dans la prise en charge des convulsions sont :

a	Administrer le diazépam
b	Récupérer des résultats de laboratoire
c	Prendre une voie veineuse
d	Aider la mère à allaiter

EXAMEN BLANC INFAS DALOA - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN PÉDIATRIE

14. ML est âgé de 36 mois, sa mère l'amène aux urgences pour une diarrhée glaireuse. Le germe probable à l'origine de cette diarrhée est :

a	Shigelles
b	Escherichia coli
c	Vibrion cholérique
d	Rotavirus

15. La mère de JK n'a pas respecté la prescription médicale et il présente, 4 jours plus tard, un poids de 8 kg, les yeux enfoncés, la bouche sèche et des signes évidents de déshydratation. Quelle est la quantité de SRO à administrer ?

a	500 ml
b	400 ml
c	600 ml
d	700 ml

16. La diarrhée aiguë concerne l'émission d'au moins 3 selles liquides par 24 heures depuis moins de :

a	21 jours
b	14 jours
c	10 jours
d	8 jours

17. Le plan de traitement des signes sévères de déshydratation est le :

a	Plan A
b	Plan B
c	Plan C
d	Plan D

18. DG est incapable de nouer les lacets de sa paire de tennis mais s'habille seul et raconte des petites histoires. Je conclus que DG est âgé de :

a	2 ans
b	3 ans
c	4 ans
d	5 ans

19. Les propositions suivantes concernent les signes d'un enfant souffrant de marasme. Cochez la proposition qui est retrouvée au stade de début de cette maladie.

a	Fonte graisseuse et musculaire
b	Retard pondéral inférieur à 60 % du poids idéal théorique
c	Affamé et porte le doigt à la bouche
d	Alopécie avec le reste des cheveux normaux non décolorés

20. Les propositions suivantes sont relatives à la bonne pratique de la réanimation du nouveau-né en salle de naissance sauf une. Cocher cette proposition.

a	Essuyer l'enfant
b	Vérifier la respiration
c	Porter un bonnet
d	Pincer le mamelon

21. Les séquelles neurologiques et neurosensorielles au cours du paludisme sont les suivantes sauf une, laquelle ?

a	Paralysie
b	Troubles du tonus
c	Myosite
d	Hypoacousie

22. Le paludisme grave est causé par l'espèce plasmodiale suivante :

a	Vivax
b	Ovale
c	Knowlésie
d	Falciparum

23. Les facteurs de mauvais pronostic au cours de la méningite purulente sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Âge de moins de 5 ans
b	Virulence du germe
c	Malnutrition
d	Retard de diagnostic et prise en charge

24. Les principaux virus responsables des infections respiratoires aiguës sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Virus para influenzae
b	Herpès simplex virus
c	Rhinovirus
d	Virus respiratoire syncytial

25. Ces affirmations concernant la bronchiolite sont justes sauf une. Laquelle ?

a	Causée par le virus respiratoire syncytial
b	Respiration sifflante
c	Fièvre et rhume
d	Plus fréquent après 2 ans

EXAMEN BLANC INFAS DALOA - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN PÉDIATRIE

26. Dans la prise en charge de la bronchiolite, l'agent de santé a pour rôle propre :

a	Conseils à la mère sur l'hygiène
b	Montrer la technique de la DRP à la mère
c	Accompagner l'enfant en ORL
d	Administrer un antipyrétique

27. Les infections respiratoires basses sont les suivantes sauf une, laquelle ?

a	Bronchiolite aiguë
b	Sinusite maxillaire aiguë
c	Laryngite aiguë
d	Bronchite aiguë

28. L'administration de zinc comprimé dans le traitement de la diarrhée chez le nourrisson de moins de 6 mois est de :

a	10 mg/j pendant 7 jours
b	15 mg/j pendant 10 jours
c	10 mg/j pendant 5 jours
d	15 mg/j pendant 7 jours

29. La quantité de SRO à administrer chez un nourrisson, après chaque selle molle dans le plan A de traitement, est :

a	50-100 ml
b	25-50 ml
c	100-200 ml
d	Autant qu'il en voudra

30. Les soins propres dans la prise en charge des vomissements chez l'enfant sont les suivants, sauf un, lequel ?

a	Nettoyer l'enfant
b	Aider à alimenter l'enfant
c	Administrer du Vogalène
d	Surveiller l'enfant

QCD

31. La méningite est l'inflammation aiguë des méninges par des bactéries, responsable d'une suppuration donnant au liquide céphalorachidien un aspect clair.

a	b
Vrai	Faux

32. L'enfant expatrié, venant pour la première fois dans une zone endémique, est à risque de faire le paludisme.

a	b
Vrai	Faux

33. Un encombrement de l'arbre respiratoire au niveau de la zone de conduction se manifeste par une perturbation au niveau des échanges gazeux.

a	b
Vrai	Faux

34. Le paracétamol est administré à la posologie de 15 mg par kilogramme toutes les 6 heures si fièvre.

a	b
Vrai	Faux

35. L'anorexie du nourrisson est un trouble du comportement alimentaire consécutif à une cause organique.

a	b
Vrai	Faux

36. Le sevrage précoce est un facteur favorisant la survenue de l'anémie.

a	b
Vrai	Faux

37. La pose d'une transfusion sanguine est un rôle de collaboration.

a	b
Vrai	Faux

38. Le nourrisson allaité qui émet 3 à 4 selles par jour souffre d'une diarrhée aiguë.

a	b
Vrai	Faux

39. Une fièvre qui évolue depuis 15 jours est une fièvre prolongée.

a	b
Vrai	Faux

40. Laisser l'enfant avec sa mère 10 heures par jour est l'une des conditions de l'initiative Hôpitaux Amis des Bébés (IHAB).

a	b
Vrai	Faux

41. L'électrophorèse de l'hémoglobine fait partie du bilan prénatal recommandé.

a	b
Vrai	Faux

EXAMEN BLANC INFAS DALOA - SEPTEMBRE 2026
ÉPREUVE DE SOINS INFIRMIERS EN PÉDIATRIE

42. Le nourrisson allaité qui émet 3 à 4 selles par jour souffre d'une diarrhée aiguë.

a	b
Vrai	Faux

43. La lèvre inférieure du bébé éversée et l'aréole peu visible en haut est un critère de bon positionnement au sein.

a	b
Vrai	Faux

44. Le surfactant est un film tensioactif sécrété par les cellules pneumocytes I des poumons.

a	b
Vrai	Faux

45. L'entérocolite est un problème lié à la prématurité.

a	b
Vrai	Faux

46. Le manque de soutien psychologique de la mère est un facteur de déclin de l'allaitement exclusif.

a	b
Vrai	Faux

47. L'enveloppement humide est un rôle propre de l'agent de santé dans la prise en charge de la fièvre chez l'enfant.

a	b
Vrai	Faux

48. Des crises convulsives subintrantes sans reprise de la conscience intercritique réalisent un état de mal convulsif.

a	b
Vrai	Faux

49. L'hyperparasitémie supérieure à 4 % chez le sujet immun est un critère clinique de gravité du paludisme grave.

a	b
Vrai	Faux

50. JL a 4 ans, il présente seulement une fièvre et 2 vomissements ce jour. Le TDR paludisme réalisé est positif. Le traitement à administrer est l'artéméther injectable.

a	b
Vrai	Faux

51. Le stress et le manque d'affection favorisent les vomissements du nourrisson.

a	b
Vrai	Faux

52. Le temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes est un signe de bonne tolérance de la fièvre.

a	b
Vrai	Faux

53. Les téguments chauds et érythrosiques sont des signes de bonne tolérance de la fièvre.

a	b
Vrai	Faux

54. Le syndrome extrapyramidal qui survient chez l'enfant après administration de l'antiémétisant se traite avec du diazépam.

a	b
Vrai	Faux

55. Le nourrisson présentant une diarrhée aiguë sans signe de déshydratation boit avec avidité.

a	b
Vrai	Faux

56. L'Haemophilus influenzae est l'un des principaux germes responsables de la méningite bactérienne.

a	b
Vrai	Faux

57. Devant une fièvre aiguë, vous collaborez avec le médecin à la réalisation d'un tubage gastrique BK.

a	b
Vrai	Faux

58. La goutte épaisse et le frottis sanguin réalisés au lit du malade apportent la confirmation du paludisme à Plasmodium falciparum.

a	b
Vrai	Faux

59. La réaction fébrile postvaccinale est une étiologie des fièvres aiguës.

a	b
Vrai	Faux

VERSION D

MINISTÈRE DE LA SANTÉ RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE ET UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ

ANTENNE DE DALOA

EXAMEN BLANC DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER (ÈRE)

Session du 19 au 20 septembre 2026

ÉPREUVE DE SANTÉ PUBLIQUE

QCD

Répondre aux questions Vrai = A ou Faux = B, sachant qu'une bonne réponse = 1 point, une mauvaise réponse = -1 et une absence de réponse = 0 point.

1. Le superviseur ayant le style autocratique cherche à tout comprendre. A B

2. L'intervention en approche épidémiologique repose sur le contrôle, l'éradication, l'élimination et la maîtrise de la maladie. A B

3. Le processus d'évacuation des ordures ménagères comprend le stockage et le ramassage. A B

4. Le taux de létalité permet d'évaluer la qualité de la prise en charge des malades. A B

5. La participation communautaire a été prônée en 1985 à Bamako pour garantir la mise en œuvre et la pérennisation d'un système de financement communautaire. A B

6. L'absence d'humidité dans le logement est un critère de salubrité de l'habitat relatif aux besoins physiologiques. A B

7. Le bassin de desserte correspond à une zone située dans un rayon de 15 km autour d'un centre de santé. A B

8. Le district est l'unité sanitaire décentralisée regroupant tous les services sanitaires publics tant en milieu urbain que rural. A B

9. Les doses de vaccins perdues pour que la vaccination ait lieu sont considérées comme des doses sacrifiées. A B

10. Plus le taux de perte est élevé, moins le facteur de perte est élevé. A B

VERSION D

11. Dans les cas de poliomyélite à virus de type sauvage, l'excrétion virale dans les selles augmente au-delà de deux semaines après le début de la paralysie. A B

12. Le sujet d'intérêt en épidémiologie est le malade. A B

13. En matière de vaccination, l'intervalle minimum existe. A B

14. Les centres antituberculeux sont situés au niveau périphérique du versant administratif du PNLT. A B

15. Le seuil d'alerte est le niveau à partir duquel la riposte doit être déclenchée face à une menace d'épidémie. A B

16. L'accessibilité aux soins consiste à mettre les soins de santé à proximité des populations et à un prix non exorbitant. A B

17. Le non-respect de la politique du flacon entamé est un facteur évitable de perte de vaccins. A B

18. En Côte d'Ivoire, la politique des SSP comprend deux composantes préventives et trois composantes curatives. A B

19. On peut administrer le VPI à tous les enfants ayant un âge compris entre 0 et 23 mois sans exception. A B

QCM

Cochez les bonnes réponses sachant qu'une bonne réponse = 1 point et une mauvaise réponse = 0 point.

20. Parmi les éléments suivants, identifier ceux qui constituent des différentes catastrophes naturelles :

A. La guerre
B. Les cyclones
C. Les tremblements de terre
D. Le tsunami
E. Les graves accidents de circulation
F. Les génocides

21. Les vaccins du PEV qui sont sensibles à la lumière sont :

A. BCG
B. RR
C. VAA
D. Penta

VERSION D

22. La liste ci-dessous contient des dates et des événements relatifs à la politique des SSP :

1. 1997	a. Initiative de Bamako
2. 06 au 12/09/1978	b. Conférence d'Alma-Ata
3. 1991	c. Lancement officiel des SSP en C.I.
4. 1993	d. Mise en œuvre effective des SSP en C.I.
5. 1987	e. Définition des niveaux d'application des SSP
6. 1985	f. Réunion du comité d'experts africains à Brazzaville

Trouvez les bonnes combinaisons entre les dates et les événements.

A. (1, f) ; (2, b) ; (3, c) ; (4, d) ; (5, a) ; (6, e)
B. (1, f) ; (2, c) ; (3, b) ; (4, a) ; (5, d) ; (6, e)
C. (1, e) ; (2, b) ; (3, c) ; (4, d) ; (5, a) ; (6, f)
D. (1, c) ; (2, f) ; (3, a) ; (4, b) ; (5, e) ; (6, d)
E. (1, d) ; (2, e) ; (3, f) ; (4, c) ; (5, b) ; (6, a)

23. Quel est l'ordre normal d'administration de ces groupes d'antigènes conformément au calendrier de vaccination du PEV ivoirien ?

1. Penta 3 + VPO-3 + PCV-13-3 + VPI
2. Penta 2 + VPO-2 + PCV-13-2 + Rota 2
3. VPO-0 + BCG + DN-HepB
4. Penta 1 + VPO-1 + PCV13-1 + Rota 1
5. RR + VAA + Men A

A. (1,2,3,4,5) B. (3,4,2,1,5) C. (3,4,1,2,5) D. (4,3,2,1,5)

24. Parmi les maladies suivantes, indiquez celles qui sont sous surveillance en Côte d'Ivoire.

A. Le choléra
B. Le paludisme
C. La fièvre hémorragique virale
D. La dracunculose
E. Les infections respiratoires aiguës
F. Les infections urinaires

VERSION D

25. Parmi les critères suivants, indiquez ceux qui permettent de sélectionner un problème prioritaire de santé :

A. L’ampleur du problème
B. La gravité du problème
C. La population totale de la localité
D. Le niveau d’instruction des populations
E. La vulnérabilité du problème
F. La durée des interventions

26. Le nombre de doses et la voie d’administration correcte du vaccin Rotarix est :

A. Deux doses de 0,5 ml en IM
B. Trois doses de 0,5 ml en IM
C. Deux doses de 2 ml par voie orale
D. Trois doses de 2 ml par voie orale

27. Parmi les problèmes suivants causés par l’abus des drogues, indiquez ceux qui sont d’ordre sanitaire :

A. L’absentéisme scolaire
B. L’hallucination
C. Les accidents de la voie publique
D. Le délire
E. Le suicide
F. L’asthénie

28. Parmi les propositions suivantes, cocher celles qui sont les missions assignées à un district sanitaire :

A. Évaluation des agents de santé
B. Promotion des soins de santé primaires
C. Suivi et évaluation des activités
D. Coordination des activités sanitaires

Entourer la bonne réponse

VERSION D

29. Selon le rythme des activités de monitorage en Côte d'Ivoire, précisez les périodes de monitorage.

A. Décembre 2023 à mai 2024

B. Janvier 2023 à juin 2023

C. Juin 2024 à novembre 2024

D. Juillet 2023 à décembre 2023

30. Parmi les antigènes ci-dessous, cochez ceux qui ont pour site d'administration la cuisse.

A. BCG ; Td ; PCV 13

B. VPI ; Rota

C. DN hépatite ; VPI ; Men A ; VAP

D. VPO ; HPV ; RR

31. Le système d'évacuation des excréta le plus couramment utilisé sans entraînement des matières fécales est :

A. La fosse septique

B. La fosse d'aisance

C. La latrine à fosse

D. Le réseau d'égouts

32. Quelle méthode permet de lutter contre les moustiques adultes ?

A. Combler les flaques d'eau

B. Curer les caniveaux

C. Dormir sous une moustiquaire imprégnée

D. Vider les récipients contenant de l'eau

33. Parmi les facteurs susceptibles d'influencer le changement social de comportement ci-dessous, indiquer ceux qui sont d'ordre externe.

A. La perception

B. Le milieu social

C. La culture

D. Les caractéristiques personnelles et psychologiques

VERSION D

34. En cas de paralysie flasque aiguë, un prélèvement des selles se fait :

A. Entre J10 et J14

B. Entre J14 et J60

C. Entre J61 et 06 mois

D. Après 06 mois

35. Une endémie est un phénomène :

A. Limité dans le temps et limité dans l'espace

B. Illimité dans le temps et illimité dans l'espace

C. Limité dans le temps et illimité dans l'espace

D. Illimité dans le temps et limité dans l'espace

36. Parmi ces antigènes suivants, lequel est vivant atténué ?

A. Td

B. VPO

C. VPI

37. La MOBSOC a pour but :

A. Promouvoir la santé communautaire

B. Changer une situation sociale et communautaire en un sens favorable à la société selon ses valeurs et motivations

C. Inciter la communauté à se mobiliser et à mobiliser leurs propres moyens pour remédier aux problèmes

38. Parmi les actions suivantes, une seule permet d'améliorer la saveur et l'odeur de l'eau :

A. L'ébullition

B. Usage de charbon de bois

C. La sédimentation

D. La filtration

E. L'ionisation

VERSION D

ÉTUDE DE CAS

Après votre formation, vous êtes affecté(e) au centre de santé de Sinikosson où travaillent deux infirmiers et une sage-femme diplômés d'État.

La population totale de ce centre de santé a été estimée à 5 000 habitants au 31/12/2019 et à 5 100 habitants au 1er/01/2021.

Pendant l'année 2021, les données sanitaires suivantes ont été relevées dans ce village :

- 25 naissances enregistrées dont 04 mort-nés ;

- 105 cas de paludisme et 35 cas de diarrhées ;

- 03 décès de femmes enceintes dont 01 à la suite d'une chute sur la route du champ ;

- 06 femmes décédées dont 04 après 5 semaines de suites de couches et 02 après 7 semaines de suites de couches ;

Par ailleurs, le dispensaire et la maternité disposent de 18 lits et le ratio personnel infirmier/lit du dispensaire est de 0,2.

À partir du texte ci-dessus, répondre aux questions ci-dessous.

QUESTIONS

39. Quel est le taux d'accroissement annuel de la population de Sinikosson ?

A. 0,02 %
B. 2 %
C. 0,2 %

40. Quelle est la population totale en 2021 ?

A. 5100
B. 5200
C. 5202

41. Quelle est la population moyenne en 2021 ?

A. 5151
B. 5150
C. 5050
D. 5253

42. Quel est le nombre de femmes en âge de reproduction en 2021 ?

A. 1020
B. 1030
C. 1041

VERSION D

43. Quel est le nombre des enfants de 0 à 23 mois en 2021 ?

A. 352
B. 256
C. 355
D. 445

44. Calculez le besoin théorique mensuel de RR pour vacciner ces enfants de 0 à 23 mois.

A. 65 doses
B. 66 doses
C. 70 doses
D. 80 doses
E. 64 doses

45. Calculez le nombre de lits disponibles à la maternité.

A. 6 lits
B. 10 lits
C. 8 lits
D. 12 lits